要介護認定調査票・ペルソナ症例 10

要介護認定基本調査・主治医意見書・概況調査統合データファイル

1. 調査実施者および調査対象者の情報

調査対象者氏名	加藤 茂（かとう しげる）	**年齢 / 性別**	76歳 / 男性
要介護度	要介護2	**調査実施者**	居宅介護支援事業所ケアマネジャー

2. 現在受けているサービスの状況（概況調査）

【在宅利用・介護給付】通所介護（デイサービス）週2回、訪問リハビリテーション週2回、福祉用具貸与（杖・歩行器）

3. 置かれている環境等（家族・居住環境・傷病等）

【家族状況】長女夫婦が徒歩5分の近隣に居住。妻とは数年前に死別し独居。
【居住環境】バリアフリーマンション。
【主な介護者】なし（本人および近隣の長女がサポート）。
【傷病・既往歴】骨粗鬆症、左大腿骨頚部骨折術後。

4. 主治医意見書（医学的記載事項）

主傷病名	骨粗鬆症、左大腿骨頚部骨折術後
傷病の経過・治療内容	左大腿骨頚部骨折の手術を経て杖歩行は可能となったが、下肢筋力の低下および転倒に対する強い恐怖心（転倒恐怖症）が残存している。
医学的管理の必要性	骨粗鬆症治療薬（ビスホスホネート製剤等）の投与、定期的な整形外科的フォローアップ、リハビリテーションの継続。
身体障害に関する意見	左股関節周辺の軽度筋萎縮と可動域制限。杖使用にて屋内移動は自立しているが、屋外の単独歩行には慎重を要する。
精神・認知機能の意見	認知機能は完全に正常。性格は社交的で前向きであるが、身体の自由がきかないことや将来への焦り・不安感がある。
特別医療・ケアの必要性	特別な医療処置は不要だが、再骨折予防のための骨粗鬆症管理および転倒予防リハビリテーションが必要。
介護に関する医学的意見	独居であるが近隣に長女夫婦が居住しサポートしている。本人の「地域社会の活動や趣味に復帰したい」という意欲が高いため、訪問リハビリテーションおよびデイサービスを通じた身体機能回復と社会参加の促進を図るケアプランが適切。

5. 要介護認定基本調査（全74項目）

第1群：身体機能・起居動作（全13項目）

1. 麻痺（上肢）：なし (1)
2. 麻痺（下肢）：なし（骨折後の筋力低下・可動域制限） (2)
3. 関節拘縮（上肢）：なし (1)
4. 関節拘縮（下肢）：左股関節可動域制限・筋萎縮軽度 (2)
5. 寝返り：自立 (1)
6. 起き上がり：自立 (1)
7. 座位保持：自立 (1)
8. 立位保持：自立（杖使用） (1)
9. 歩行：杖を使用して屋内・屋外とも可能だが慎重 (2)
10. 立ち上がり：手すりを使用して自立 (1)
11. 片足立ち：Impossible (4)
12. 洗顔：自立 (1)
13. 爪切り：自立 (1)

第2群：生活機能（全12項目）

1. 移乗：自立 (1)
2. 移動（屋内）：杖または手すり伝い (1)
3. 移動（屋外）：一部介助・見守り（転倒への恐怖心強く娘が付き添いまたは車椅子） (2)
4. 食事摂取：自立 (1)
5. 排泄（トイレ動作）：自立 (1)
6. 排泄（排便コントロール）：自立 (1)
7. 衣服着脱（上衣）：自立 (1)
8. 衣服着脱（ズボン等）：一部介助（椅子に腰掛けて実施） (2)
9. 入浴：一部介助（浴槽またぎに補助手すりと見守り） (2)
10. 口腔清潔：自立 (1)
11. 洗髪：自立 (1)
12. 買い物：一部介助（近所のスーパーには杖で行くが重いものは娘がサポート） (2)

第3群：認知機能（全9項目）

1. 意思の伝達：できる (1)
2. 麻痺等による意思伝達の困難さ：なし (1)
3. 短期記憶：しっかりしている (1)
4. 日付の理解：わかる (1)
5. 場所の理解：わかる (1)
6. 自分の名前：わかる (1)
7. 生年月日：わかる (1)
8. 同行者の認識：わかる (1)
9. 徘徊：なし (1)

第4群：精神・行動障害（全15項目）

1. 薬の過量服薬：なし (1)
2. 収集癖：なし (1)
3. 落ち着きのない行動：なし (1)
4. 失敗に対するこだわり：なし (1)
5. 外出先での迷子：なし (1)
6. 介護への抵抗：なし (1)
7. 羞恥心の喪失：なし (1)
8. 不潔行為：なし (1)
9. 異食：なし (1)
10. 幻覚・妄想：なし (1)
11. 夜間不穏：なし (1)
12. 大声を出す：なし (1)
13. 徘徊：なし (1)
14. 興奮状態：なし (1)
15. 暴力行為：なし (1)

第5群：社会生活への適応（全6項目）

1. 薬の管理：自立（几帳面に自分で管理） (1)
2. 金銭管理：自立 (1)
3. 簡単な調理：一部介助（本格的調理は長女や宅配弁当利用） (2)
4. 電話の利用：自立 (1)
5. 社会的交流：一部介助（外出が減り孤立感あり、デイサービスの集まりを楽しみにしている） (2)
6. 日常の意思決定：自立 (1)

6. 特記事項（総合所見・ケアマネジメント留意点）

76歳独居男性。左大腿骨頚部骨折術後のリハビリ期にあり杖歩行は自立しているものの転倒恐怖症が強い。認知機能は正常でリハビリへの意欲が高い。近隣の長女がサポートしているが「もっと元気になって地域の活動や趣味に復職したい」という希望を持つ。高齢者の社会参加促進、地域コミュニティ結びつきアプリ、リハビリ進捗管理アプリの検証に最適。